



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : ماجده كامل حسن سليم
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : شبرا
رقم البطاقة : 26901122100621 رقم التليفون : 01155773114
العنوان : =
العمر (تاريخ الميلاد) : 12-01-1969 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / ----- / أ.د. / ----- / د. / ----- / د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ماجده كامل حسن سليم National ID: 26901122100621	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
وزارة الداخلية

ماجده
كامل حسن سليم
قرية اسكر
مركز كنفك بالجيزة



٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

K90027373

Name: ماجده كامل حسن سليم		
MR. : 8033		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient was diagnosed with post-mastectomy recurrent breast cancer involving the right breast (RT) with a pathological stage of PT2 N3, estrogen receptor (ER) 8/8 positive, progesterone receptor (PR) 6/8 positive, and HER2-negative. The disease was classified as recurrent (REC) and the patient received adjuvant chemotherapy (AC) followed by radiotherapy (RT) beginning on 31 January 2021. Subsequent management included initiation of hormonal therapy with femara and targeted therapy with zometa for new bone metastases involving the ribs, which were symptomatic with pain. The current plan is to continue the prescribed endocrine and bone-targeted therapies while monitoring disease status and symptom control.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 19-09-2026
	dina makram	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

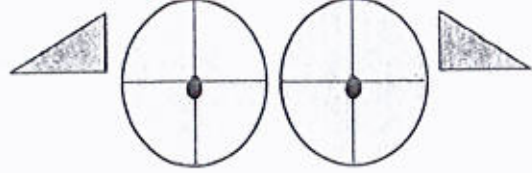


مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

الست المصرية
صحة
مصر

MDT FORM

Name	سارة كمال حسن
Age	
MRN	
ID	
Co morbidity	



Clinical Data

Bx:	SM:
IHC: ER: 8/8 PR: 6/8 Her2: 1 Ki67: 40%	Mets Workup: free bone scan CT CAP. scan
pT ₂ N ₃ M	
COMMENT: Rt MRM 1/2021 -> IDC G2 pT ₂ N ₃ , ER ended ACx4 - taxol x12 adjuvant for PORT+ + adj Arimidex 5 yrs.	

MDT OUTCOME & PLAN

--	--	--	--

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
محمد كمال	د. د. د. د.		



Patient Name: Magda Kamel Hassan Selim	Date : 15/02/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 56 Year(s)
Medical ID: 5956/2020	Pat. ID: 18961

LEFT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Technique

- LEFT breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- The left breast is scattered fibroglandular densities (ACR B)
- Left breast UOQ cluster of microcalcification about 2.5 cm from the nipple with no underlying suspicious lesion by US.
- Complementary ultrasound also showed no left breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free right supra and infra regions.

Opinion:

- Right MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Left breast UOQ cluster of microcalcification (BIRADS 3) for follow up by 6 months by single view mammography.

Yours truly

Signature Dr. Youmna tarek

15/02/2025 2:07 PM

Pathology Report

Name: ماجة كامل حسن

Age: 51 years.

Clinical data: Right breast mass

Specimen type: Right MRM and axillary clearance

Date (Received): 31/1/2021

Date (reported): /1/2021

Lab. Number : 195/2021

Hospital Number 5956/2020 نفقة دولة

Gross Description:

Right MRM specimen: measured 23x18x6cm, covering skin 20x18cm, axillary fat 6x3cm. Nipple was unremarkable grossly, cut sections revealed ill - defined firm grayish white mass at the UOQ measured 3x2x1.5cm away 2.5cm from deep margin and 1.5cm from skin. Another suspicious rubbery grayish brown mass measure 2x2x1cm at LIQ was recorded. Axillary fat dissection revealed 12 nodules up to 2cm.

Microscopic Examination:

histopathological examination of sections prepared from the tumor masses reveals an infiltrating malignant epithelial growth made up of small groups and thin cords of pleomorphic hyperchromatic malignant lobular epithelial cells. And malignant epithelial growth made up of groups and sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant ductal epithelial cells is present. Stromal desmoplasia is moderate. Cellular and nuclear atypia are moderate [grade II]. Focal intraduct component could be detected. All of the 12 lymph nodes detected show metastatic deposit [Nodal score is 12/12 = N3]. The nipple, areola and surgical margins are free.

Diagnosis:

Multicentric mixed invasive ductal and lobular carcinoma GIL
Focal in situ ductal component.
Positive L.V emboli
Free nipple, areola, skin and soft tissue margins.
Positive metastatic deposits in 12/12 axillary lymph nodes with focal extracapsular extension.
pT2, pN3, pMx.

Prof. Dr. Eubna Omar.
Dr. Mona Mohamed



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
«هرمل» سابقا

Name : فايزة كمال

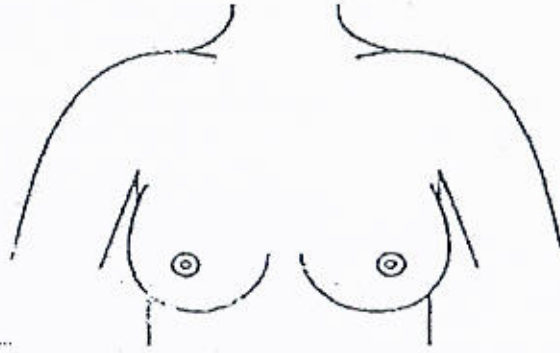
Age : 54

No. : 31/1/2021

MDT FORM

Clinical data :

Postmenopausal
RT Breast cancer
Early RT/HR



on 31/1/2021

IDC T2, N3, M0

Reason of discussion:

for IDC

Breast

2 neoadjuvant cycles Adjuvant

MDT Outcome and Plan

Chemotherapy

4 AC, 12 Taxol

Signature :

فايزة كمال
31/1/2021



NASSER INSTITUTE
ONCOLOGY CENTER



وزارة الصحة
أسامة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى ناصر
Nasser Institute Hospital
مركز الأورام



NUCLEAR MEDICINE UNIT

وحدة الطب النووي

Patient Name: Magda Kamel Hassan
Referring physician: P. of.

Date: 10/4/2021

^{99m}Tc-MDP BONE SCAN

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP.

Report:

- Degenerative changes at the dorsal and lumbar vertebrae, more at mid dorsal for follow up.
- Arthritic changes at knees and shoulders, more at right shoulder for follow up.
- Otherwise the rest of surveyed skeleton is free from serious bone lesions.
- Both kidneys are normally seen.

Conclusion:

No definite evidence of metastatic osseous deposits.
Follow up bone scan is advised.

Thanks for reference .

Nuclear Medicine Unit
Huda Fathy, M.D
Magdy Kotb, M.D.